

PAUSE CARDIO

Nouveautés de la semaine du 3 octobre 2026

9 nouveautés cette semaine — aucune ne modifie la pratique dans l'immédiat.

INSUFFISANCE CARDIAQUE À connaître Recommandations iCARDIO Alliance 2026

2026 iCARDIO Alliance Global Implementation Guidelines on Heart Failure.

Journal of Cardiac Failure · 1er octobre 2026 · Recommandations, mise à jour de la version 2025

L'iCARDIO Alliance publie la version 2026 de ses recommandations mondiales de mise en œuvre sur l'insuffisance cardiaque, après une première édition en 2025. Le document couvre l'insuffisance cardiaque aiguë et chronique, à fraction d'éjection réduite, préservée ou améliorée, ainsi que les cardiomyopathies, et intègre les traitements récents dans la prise en charge de référence. Sa particularité est de proposer, à côté des recommandations fondées sur les preuves, des recommandations d'« ajustement économique » pour les situations où les ressources sont limitées ou très limitées, afin de rester applicable dans tous les systèmes de santé.

En pratique : pour un cardiologue exerçant dans un système de santé bien doté, ce document ne remplace pas les recommandations européennes, mais il offre une synthèse mondiale actualisée et, surtout, des recommandations explicites pour les situations où tous les traitements ne sont pas disponibles. Il mérite d'être connu de ceux qui enseignent, coopèrent avec des centres moins dotés ou doivent établir des priorités.

[Article original](#)

IMAGERIE CARDIAQUE À connaître Recommandations EACVI / ESC (consensus clinique)

Implementation of cardiac magnetic resonance imaging in everyday cardiology practice.

European Heart Journal · 30 septembre 2026 · Consensus clinique de l'EACVI et du Conseil ESC de cardiologie pratique

L'Association européenne d'imagerie cardiovasculaire (EACVI) et le Conseil ESC de cardiologie pratique publient un document destiné au cardiologue qui n'est pas expert en IRM cardiaque. Il précise la place de l'examen dans la prise en charge des cardiopathies au quotidien : indications, valeur pronostique et limites dans le diagnostic et le suivi de la cardiopathie ischémique, de l'insuffisance cardiaque, des cardiomyopathies, des valvulopathies, des aortopathies, des masses cardiaques, des atteintes péricardiques et des cardiopathies congénitales de l'adulte. Il explique les principales séquences et la mesure de la fonction cardiaque, et donne des conseils pour les patients porteurs d'un dispositif implantable, de plus en plus nombreux à avoir besoin d'une IRM au cours de leur vie.

En pratique : c'est le document à garder sous la main pour savoir quand demander une IRM cardiaque, ce qu'elle apporte au diagnostic et au pronostic, ce qu'elle ne montre pas, et pour comprendre les séquences citées dans le compte rendu. Il aide aussi à répondre à la question, de plus en plus fréquente, du patient porteur d'un stimulateur ou d'un défibrillateur qui a besoin d'une IRM.

[Article original](#)

No-Touch vs Conventional Vein Grafts in Coronary Surgery: Seven-Year Clinical Outcomes of the SWEDEGRAFT Randomized Clinical Trial.

JAMA Cardiology · 30 septembre 2026 · Suivi à 7 ans d'un essai randomisé, 900 patients

Le prélèvement « no-touch » de la veine saphène, qui conserve le tissu périvasculaire autour du greffon, pourrait améliorer la perméabilité des pontages, mais son effet sur les événements cliniques à long terme restait incertain. Dans ce suivi préspecifié à 7 ans de l'essai randomisé SWEDEGRAFT (900 patients opérés d'un pontage isolé, hors urgence vitale), le critère principal associant décès toutes causes, infarctus du myocarde et nouvelle revascularisation est survenu chez 19,8 % des patients du groupe no-touch et chez 20,4 % de ceux du groupe conventionnel (HR 0,98 ; IC95 % 0,73–1,31). Aucun des critères secondaires ne différait significativement. Compte tenu de l'excès de complications de cicatrice de jambe déjà rapporté, le bénéfice clinique net du no-touch en routine n'est pas établi.

En pratique : à 7 ans, le prélèvement no-touch de la veine saphène n'a pas réduit les décès, les infarctus ni les nouvelles revascularisations par rapport au prélèvement conventionnel. Avec l'excès de complications de cicatrice de jambe déjà rapporté, ces données ne justifient pas d'en faire la technique de routine.

[Article original](#)

Cardiovascular safety of orforglipron versus insulin glargine in adults with type 2 diabetes at increased cardiovascular risk (ACHIEVE-4): a phase 3, event-driven, randomised, open-label, non-inferiority, active comparator trial.

The Lancet · 30 septembre 2026 · Essai de phase 3, 2 749 patients

L'orforglipron est un agoniste oral non peptidique du récepteur du GLP-1 ; à la différence des agonistes peptidiques, la sécurité cardiovasculaire des agonistes non peptidiques n'avait pas encore été étudiée. Dans cet essai de phase 3 ouvert, piloté par les événements, 2 749 adultes diabétiques de type 2 en surpoids ou obèses, tous atteints d'une maladie cardiovasculaire établie ou d'une maladie rénale chronique, ont été randomisés entre orforglipron oral et insuline glargine, en une prise quotidienne. Après un suivi médian de 2 ans, le critère principal MACE-4 est survenu chez 4,2 % des patients sous orforglipron et 5,0 % sous glargine (HR 0,84 ; IC95 % 0,59–1,20), ce qui démontre la non-infériorité. Les effets indésirables digestifs ont été plus fréquents sous orforglipron, les hypoglycémies cliniquement significatives nettement moins. Les résultats annoncés par communiqué en avril 2026 sont ainsi publiés dans leur version définitive.

En pratique : la publication confirme ce qu'annonçait le communiqué : chez le diabétique de type 2 à haut risque cardiovasculaire, l'orforglipron oral se montre non inférieur à l'insuline glargine sur les événements cardiovasculaires majeurs, avec moins d'hypoglycémies mais nettement plus d'effets digestifs. Ces résultats en font une option orale en une prise quotidienne dont la sécurité cardiovasculaire est jugée acceptable chez ces patients, dans les limites d'un essai à peu d'événements et à marge de non-infériorité large. Cet essai mené contre un comparateur actif ne démontre pas de protection cardiovasculaire propre, comme celle acquise pour certains agonistes peptidiques.

[Article original](#) · [Analyse](#)

Food and Health: Nutrition for Prevention and Management of Cardiovascular Disease: 2026 ACC Scientific Statement: A Report of the American College of Cardiology.

JACC · 30 septembre 2026 · Déclaration scientifique de l'ACC

L'American College of Cardiology publie une déclaration scientifique qui fait le point sur la nutrition dans la prévention et la prise en charge des maladies cardiovasculaires, du diabète de type 2, de l'obésité, de la maladie rénale chronique et du syndrome cardio-rénal-métabolique. Le document acte le passage d'une approche par nutriments isolés à une approche par aliments entiers et par régimes alimentaires, en tenant compte du degré de transformation. Les preuves disponibles vont dans le même sens : remplacer les graisses saturées par des graisses insaturées, consommer davantage de fibres et de céréales complètes, réduire le sodium et les aliments ultratransformés, en particulier les boissons sucrées et les viandes transformées, et suivre un régime de type méditerranéen, DASH, végétarien ou riche en végétaux.

En pratique : le message à transmettre tient en une phrase : privilégier une alimentation centrée sur des végétaux peu transformés, pauvre en aliments ultratransformés, en sucres ajoutés, en sel et en graisses saturées, avec des sources saines de graisses et de protéines. Le document donne au cardiologue une base argumentée pour en parler en consultation, en raisonnant par aliments et par régime plutôt que par nutriment isolé.

[Article original](#)

2026 AHA/ACC/ACS/ASNC/HRS/SCA/SCCT/SCMR/SVM Guideline for Perioperative Cardiovascular Management for Noncardiac Surgery: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines.

Circulation · 28 septembre 2026 · Recommandations, publiées conjointement dans le JACC

Les sociétés américaines de cardiologie, de chirurgie, d'anesthésie cardiovasculaire, de rythmologie, d'imagerie et de médecine vasculaire publient la version 2026 de leurs recommandations sur l'évaluation et la prise en charge cardiovasculaires de l'adulte avant, pendant et après une chirurgie non cardiaque. Le document met à jour les recommandations de 2014, qu'il déclare caduques, et y ajoute des stratégies de prise en charge fondées sur les preuves pour les maladies cardiovasculaires et les affections associées : traitements médicamenteux, surveillance périopératoire et dispositifs. Il repose sur la même recherche bibliographique, menée d'août 2022 à mars 2023, que la recommandation de 2024 au titre identique ; l'ACC présente celle-ci comme réaffirmée par le texte de 2026.

En pratique : c'est le texte de référence outre-Atlantique pour toute consultation préopératoire avant une chirurgie non cardiaque, et il remplace celui de 2014. Avant de modifier une habitude, il faut lire les recommandations elles-mêmes, vérifier ce qui a changé par rapport à la version de 2024, et les confronter aux recommandations européennes de 2022.

[Article original](#)

Stenting Technique and Clinical Outcome in True Bifurcation PCI: Insights From the OCTOBER Trial.

JACC: Cardiovascular Interventions · 28 septembre 2026 · Analyse post hoc, 1 201 patients

Cette analyse post hoc de l'essai OCTOBER porte sur 1 201 patients traités par angioplastie d'une bifurcation coronaire vraie, avec ou sans guidage par tomographie par cohérence optique (OCT). La présentation clinique aiguë, l'atteinte du tronc commun et la sévérité de la lésion de la branche latérale sont les principaux facteurs qui conduisent à poser deux stents plutôt qu'un. Selon la technique réellement appliquée, un seul stent s'accompagne de moins d'événements cardiaques majeurs à 2 ans que deux stents (9,0 % contre 13,9 % ; HR ajusté 1,53 ; IC95 % 1,04–2,27 pour deux stents), sans interaction avec le guidage OCT. Selon la stratégie planifiée, en revanche, il n'y a pas de différence significative. Les taux d'événements les plus bas sont observés avec un stent unique posé sous OCT.

En pratique : ces données ne remettent pas en cause le choix d'un stent unique quand la bifurcation le permet, et elles plaident pour le guidage OCT, en particulier quand une technique à deux stents comme le DK-crush s'impose, sous la réserve d'un sous-groupe de petite taille. Elles ne démontrent pas qu'un stent vaut mieux que deux à lésion égale : c'est la complexité de la lésion qui dicte la technique et porte le risque.

[Article original](#)

Retatrutide, a Triple Hormone Receptor Agonist, for Treatment of Obesity.

NEJM · 29 septembre 2026 · Essai de phase 3, 2 339 patients

Dans cet essai de phase 3 en double insu, 2 339 adultes obèses non diabétiques ont reçu pendant 80 semaines du rétatrutide, agoniste des récepteurs du GIP, du GLP-1 et du glucagon en injection hebdomadaire, à 4, 9 ou 12 mg, ou un placebo. La variation moyenne du poids a été de -17,6 %, -23,7 % et -25,0 % selon la dose, contre -3,9 % sous placebo. Chez les participants souffrant d'arthrose du genou, la douleur a diminué davantage sous rétatrutide, et chez ceux atteints d'apnée obstructive du sommeil, l'index d'apnées-hypopnées a baissé davantage. Les effets indésirables les plus fréquents sont digestifs, et l'essai ne porte sur aucun critère cardiovasculaire.

En pratique : aux doses les plus fortes, le rétatrutide fait perdre près d'un quart du poids initial, avec des effets mesurables sur l'arthrose du genou et l'apnée du sommeil. Pour le cardiologue, c'est une molécule à suivre, pas encore à prescrire : la démonstration d'un bénéfice sur les événements cardiovasculaires, comme l'a apportée le sémaglutide dans SELECT, reste à faire.

[Article original](#)

Impact of Undertreated Antithrombotic Therapy on Adverse Patient Outcomes: A Scientific Statement From the American Heart Association.

Circulation · 1er octobre 2026 · Déclaration scientifique de l'AHA

L'American Heart Association consacre une déclaration scientifique au sous-traitement antithrombotique, qui recouvre l'omission du traitement, la non-observance, le sous-dosage et les situations cliniques qui aboutissent à des taux infrathérapeutiques. De nombreux patients atteints de fibrillation atriale, de maladie thromboembolique veineuse ou d'artériopathie des membres inférieurs restent non traités ou reçoivent une dose d'anticoagulant insuffisante, par écart aux recommandations, par mauvaise perception du rapport entre risque hémorragique et risque thrombotique ou par inégalité d'accès aux soins. Ce sous-traitement augmente les AVC ischémiques, les embolies systémiques, les récurrences thrombotiques et la mortalité. Le document propose une démarche structurée et interprofessionnelle de « stewardship » antithrombotique pour combler ces écarts.

En pratique : le document rappelle que, dans la fibrillation atriale, la maladie thromboembolique veineuse et l'artériopathie des membres inférieurs, la crainte de l'hémorragie et l'écart aux recommandations conduisent encore à ne pas traiter ou à sous-doser, au prix d'AVC, d'embolies et de récurrences évitables. Le premier geste de la démarche de « stewardship » que l'AHA invite à organiser en équipe consiste à vérifier, à chaque consultation, l'indication, la dose et l'observance de l'anticoagulant, le sous-dosage étant une forme de sous-traitement au même titre que l'omission.

[Article original](#)

Tableau de bord complet — toutes les sorties, recherche FR/EN, fiches de lecture : pausecardio.fr

Fiches rédigées à l'aide de l'IA — résumés à valider par le lecteur avant toute application clinique, se reporter aux articles originaux.